Op. Dr. Murat Ayata
Kulak Burun Boğaz
Kulak Burun Boğaz ve Baş Boyun Cerrahisi Uzmanı

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

AYDINLATILMIŞ ONAM FORMU

Timpanoplasti

Kulak zarı onarımı (gerekirse orta kulak kemikçik onarımı ve mastoidektomi ile birlikte)

Değerli hastamız, bu form size önerilen işlem hakkında bilmeniz gerekenleri **sade ve anlaşılır** bir dille anlatmak için hazırlanmıştır. Amacı sizi korkutmak değil, kararınızı **bilgiye dayanarak ve özgürce** vermenize yardımcı olmaktır.

Formu acele etmeden okuyunuz. Anlamadığınız her noktayı hekiminize sorunuz. Hekiminiz sizin durumunuza özel riskleri ayrıca sözlü olarak da açıklayacaktır. Onay vermek ya da vermemek tamamen sizin hakkınızdır.

HASTA VE İŞLEM BİLGİLERİ

Adı Soyadı: _____ Doğum tarihi: _____

T.C. Kimlik / Pasaport: _____ Dosya / Protokol No: _____

Telefon: _____ Bilgilendirme tarihi: _____

Planlanan işlem tarihi: _____

Form hastaya ilk iletildi (tarih / e-posta, WhatsApp, elden): _____

İşlemi yapacak ve bilgilendiren hekim: **Op. Dr. Murat Ayata**

İşlemin yapılacağı sağlık kuruluşu: _____

Taraf: ☐ Sağ ☐ Sol

Görüntüleme yöntemi: ☐ Mikroskopik ☐ Endoskopik ☐ Ameliyatta belirlenecek

Yaklaşım: ☐ Transkanal ☐ Retroaurikuler ☐ Endaural _____

Greft kaynağı: ☐ Kas zarı (temporal fasya) ☐ Kıkırdak / perikondriyum ☐ Diğer _____

Kemikçik onarımı (ossikuloplasti): ☐ Planlanmıyor ☐ Planlanıyor ☐ Gerekirse _____

Mastoidektomi: ☐ Planlanmıyor ☐ Planlanıyor ☐ Gerekirse _____

Ameliyat öncesi işitme testi (odyometri) tarihi ve özeti: _____

1 Durumunuz ve işlemin amacı

Kulak zarı, dış kulak yolunu orta kulaktan ayıran, ses titreşimlerini orta kulaktaki küçük kemikçiklere ileten ince bir zardır. Kulak zarında **delik (perforasyon)** olduğunda işitme azalır ve kulağa su veya mikrop girmesiyle **tekrarlayan kulak akıntıları** olur.

Kulak zarı delikleri çoğunlukla **kronik orta kulak iltihabı**, bazen de travma (tokat, kulak çubuğu, ani basınç değişikliği) sonucu oluşur. Küçük, yeni oluşmuş delikler kendiliğinden kapanabilir; ancak uzun süredir var olan delikler genellikle kapanmaz. Bazı hastalarda iltihap orta kulaktaki kemikçikleri de aşındırmış olabilir veya kulak arkasındaki kemik boşluklara (mastoid) yayılmış olabilir. Orta kulakta **kolesteatom** (deri hücrelerinden oluşan, kemiği aşındırarak büyüyen bir kese) varsa bu durumun tedavisi ayrıca önemlidir.

Timpanoplastinin amacı; kulak zarını kapatmak, orta kulağı iltihaptan arındırarak **kuru ve güvenli bir kulak** elde etmek ve mümkünse **işitmeyi korumak veya iyileştirmektir**.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

2 İşlem nasıl yapılır?

Ameliyat genel anestezi altında, ameliyathane koşullarında, mikroskop ve/veya endoskop kullanılarak yapılır.

1. **Yaklaşım:** Delik küçük ve uygun yerdeyse ameliyat tamamen kulak yolu içinden yapılabilir ve dışarıdan iz kalmaz. Daha büyük deliklerde veya geniş görüş gerektiğinde kulak arkasından (kulak kepçesinin arkasındaki kıvrımda) veya kulak önünden küçük bir kesi yapılır.
2. **Greftin alınması:** Kulak zarını onarmak için kişinin kendi dokusu kullanılır: genellikle kulak üzerindeki kasın zarı (temporal fasya) veya kulak kepçesinin kıkırdağı ve zarı. Bu dokular aynı kesiden veya küçük ek bir kesiden alınır.
3. **Orta kulağın temizlenmesi:** Deliğin kenarları tazelenir, kulak zarı kaldırılarak orta kulak incelenir; varsa iltihaplı doku ve yapışıklıklar temizlenir. Kemikçikler kontrol edilir.
4. **Kemikçik onarımı (gerekirse):** Kemikçik zinciri aşınmış veya kopmuşsa, hastanın kendi kemikçiği/kıkırdağı veya titanyum gibi doku dostu bir protez ile onarılabilir.
5. **Mastoidektomi (gerekirse):** İltihap veya kolesteatom kulak arkasındaki kemik boşluklara yayılmışsa bu boşluklar özel bir tur ile açılarak temizlenir.
6. **Greftin yerleştirilmesi ve kapatma:** Greft, deliğin altına veya üstüne yerleştirilir. Orta kulak ve kulak yolu eriyebilen süngerlerle desteklenir. Kesi varsa dikişle kapatılır ve kulak üzerine baskılı bir pansuman uygulanır.

Kolesteatom saptanırsa, hastalığın tamamen temizlendiğinden emin olmak için bazı hastalarda **6–12 ay sonra ikinci bir kontrol ameliyatı** planlanabilir. Bu durum size ayrıca açıklanır.

ANESTEZİ	TAHMİNİ SÜRE	HASTANEDE KALIŞ / TABURCULUK
Genel anestezi	Yaklaşık 1,5–3 saat (mastoidektomi ile daha uzun)	Genellikle aynı gün veya 1 gece

3 Beklenen faydalar ve başarı şansı

- Kulak zarındaki deliğin kapanması
- Tekrarlayan kulak akıntılarının ve iltihapların azalması veya sona ermesi; kuru ve güvenli bir kulak
- Banyo, duş ve yüzmede kulağı korumak için gereken kısıtlamaların azalması
- Mümkün olan hastalarda işitmenin korunması veya iyileşmesi
- Kolesteatom varsa hastalığın temizlenmesi ve olası ciddi komplikasyonlarının önlenmesi

Kulak zarının kalıcı olarak kapanması hastaların yaklaşık **%85–95'inde** sağlanır. İşitmede düzelme ise kemikçiklerin durumuna, iltihabın yaygınlığına ve iç kulağın sağlığına bağlıdır; işitme belirgin şekilde düzelebilir, aynı kalabilir veya nadiren azalabilir. Greft tutmazsa veya yeniden delik oluşursa ameliyat tekrarlanabilir.

4 Diğer tedavi seçenekleri

- **Takip ve kulağı kuru tutma:** Küçük, akıntısız deliklerde düzenli kontrol ve kulağı sudan koruma ile izlem yapılabilir. Delik açık kalır ve iltihaplanma riski devam eder.
- **İlaç tedavisi:** Akıntı dönemlerinde antibiyotikli kulak damlaları iltihabı geçici olarak kontrol eder; deliği kapatmaz.
- **İşitme cihazı:** İşitme kaybını telafi edebilir; ancak akıntılı kulakta kullanımı zor olabilir ve deliği kapatmaz.
- **Küçük deliklerde basit yama işlemleri:** Çok küçük deliklerde kâğıt yama veya yağ dokusu ile kapatma (miringoplasti) seçenekleri değerlendirilebilir.

5 İşlem yapılmazsa ne olur?

Ameliyat yapılmazsa kulak zarındaki delik genellikle açık kalır. Kulağa su kaçtığında veya üst solunum yolu enfeksiyonlarında akıntılar tekrarlayabilir ve zamanla işitme kaybı artabilir. Kolesteatom varsa tedavi edilmediğinde büyümeye devam eder ve **kalıcı işitme kaybı, baş dönmesi, yüz felci, menenjit veya beyin apsesi** gibi ciddi komplikasyonlara yol açabilir.

Önerilen işlemi kabul etmeme, ertelemek isteme veya ikinci bir hekim görüşü alma hakkınız vardır. Bu kararınız, size sunulan diğer sağlık hizmetlerini hiçbir şekilde olumsuz etkilemez. Verdiğiniz onayı, işlem başlamadan önce

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

istediğiniz zaman geri alabilirsiniz; ancak işlem başladıktan sonra tıbben durdurulması sakıncalı olabilecek aşamalar olabileceğini de bilmenizi isteriz.

6 İşlem öncesi hazırlık

- Ameliyattan önce işitme testi (odyometri) yapılır; gerekirse bilgisayarlı tomografi çekilir. Anestezi uzmanı tarafından değerlendirilirsiniz.
- Ameliyattan önceki **6–8 saat** boyunca hiçbir şey yememeniz ve içmemeniz gerekir (anestezi uzmanının talimatlarına uyunuz).
- Kulakta aktif akıntı varsa ameliyat öncesinde damla tedavisi ile kulağın kurutulması istenebilir.
- Ameliyat günü kulak arkasındaki saçlar bir miktar kısaltılabilir. Grip veya üst solunum yolu enfeksiyonu varsa ameliyat ertelenebilir.
- Kullandığınız **tüm ilaçları** (kan sulandırıcılar, aspirin, ağrı kesiciler, kilo verme ilaçları, hormon ilaçları dahil), **bitkisel ürünleri ve takviyeleri** (omega-3, E vitamini, ginkgo, sarımsak, ginseng, balık yağı gibi) hekiminize bildiriniz. Hekiminizin onayı olmadan kendi kendinize hiçbir ilacı kesmeyiniz.
- Bilinen **alerjilerinizi**, kanama veya pıhtılaşma sorunlarınızı, kalp, akciğer, şeker, tansiyon, tiroid gibi hastalıklarınızı, daha önce geçirdiğiniz ameliyatları ve anesteziyle ilgili sorunları mutlaka belirtiniz.
- Hamilelik ihtimaliniz varsa veya emziriyorsanız işlemden önce mutlaka söyleyiniz.
- Sigara ve nikotin ürünleri yara iyileşmesini belirgin şekilde bozar. Mümkünse işlemden en az 2–4 hafta önce bırakmanız ve iyileşme süresince içmemeniz önerilir.

7 İyileşme süreci: sizi neler bekliyor?

İlk 24–48 saat	Kulakta dolgunluk, hafif ağrı ve tıkanıklık hissi olur; ağrı kesicilerle kontrol edilir. Kısa süreli hafif baş dönmesi ve bulantı olabilir. Baskılı pansuman genellikle 1. gün çıkarılır. Ameliyatlı kulağın üzerine yatmamanız önerilir.
1–2. haftalar	Kulak yolundaki süngerler nedeniyle işitme bu dönemde **azalmış** hissedilir; bu normaldir. Kulaktan hafif kanlı akıntı olabilir. Dikişler genellikle **7–10. günlerde** alınır. Masa başı işe çoğunlukla 1 hafta içinde dönülür.
3–6. haftalar	Kulak yolundaki süngerler kontrollerde temizlenir veya kendiliğinden erir. Kulağa kesinlikle su kaçırılmamalıdır. Ağır egzersiz, ağır kaldırma ve ıkınma yaklaşık **4–6 hafta** ertelenmelidir. Uçak yolculuğu genellikle hekim onayıyla **2–4 hafta sonra** yapılabilir.
2–3. aylar	Greftin tutup tutmadığı kontrollerde değerlendirilir. Bu dönemde yapılan işitme testi, ameliyatın işitmeye etkisini gösterir. Yüzme ve kulağa su temasına genellikle hekim onayından sonra izin verilir.
6–12. aylar	Kulak zarı ve orta kulak iyileşmesini tamamlar. Kolesteatom ameliyatı olduysa düzenli kontroller ve gerekirse görüntüleme veya ikinci kontrol ameliyatı planlanır.

8 Olası riskler ve komplikasyonlar

Her tıbbi işlemde olduğu gibi bu işlemin de bazı riskleri vardır. Aşağıda **beklenen geçici etkiler** ile **komplikasyonlar** ayrı ayrı ve görülme sıklıklarına göre gruplandırılmıştır. Verilen oranlar bilimsel yayınlara dayanan **yaklaşık** değerlerdir; sizin kişisel riskiniz yaşınıza, genel sağlığınıza, sigara kullanımına ve daha önce geçirdiğiniz ameliyatlara göre daha düşük ya da daha yüksek olabilir.

Komplikasyonların büyük çoğunluğu **geçicidir** ve uygun tedaviyle düzelir. Listede çok nadir görülen ciddi durumlara da yer verilmiştir; bunların yazılmış olması sizde görüleceği anlamına gelmez, ancak bilgilenmiş karar verebilmeniz için bilmeniz gerekir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

Beklenen, geçici etkiler (komplikasyon sayılmaz; iyileşmenin doğal parçasıdır)

- Kulakta dolgunluk, tıkanıklık hissi ve ilk haftalarda işitmenin azalmış gibi hissedilmesi (kulak yolundaki süngerlere bağlı)
- Kulakta hafif ağrı, çıtırtı, su sesi veya uğultu hissi
- Kulaktan hafif kanlı akıntı (ilk günler)
- Kulak kepçesi ve kesi çevresinde geçici uyuşukluk; kulak kepçesinin biraz öne dönük görünmesi (kulak arkası yaklaşımda, haftalar içinde düzelir)

Sık görülen durumlar (çoğu geçicidir veya tedaviyle düzelir)

- **Dilde tat değişikliği** — Kulak zarının hemen arkasından geçen tat siniri (korda timpani) ameliyat sırasında gerilebilir veya nadiren kesilmek zorunda kalınabilir. Yaklaşık 100 hastadan **5–20'sinde** dilin o tarafında metalik tat, tat azalması veya ağız kuruluğu hissi olur; çoğunlukla **haftalar–aylar içinde** düzelir veya fark edilmez hâle gelir. Nadiren kalıcı olabilir.
- **Kulak çınlaması** — Ameliyat sonrası kulak çınlaması olabilir veya var olan çınlama bir süre artabilir; genellikle geçicidir.
- **Geçici baş dönmesi** — İlk günlerde hafif dengesizlik veya baş dönmesi olabilir; çoğunlukla birkaç gün içinde geçer.

Seyrek görülen durumlar

- **Greftin tutmaması veya yeniden delik oluşması** — Yaklaşık 100 hastadan **5–15'inde** kulak zarı tam kapanmayabilir veya ileride yeniden delik oluşabilir. Bu durumda kulak akıntıları devam edebilir ve **ameliyatın tekrarlanması** gerekebilir.
- **İşitmenin düzelmemesi** — Kulak zarı kapansa bile kemikçik zinciri, orta kulak havalanması veya iç kulağa bağlı nedenlerle işitme beklenen düzeyde iyileşmeyebilir. Kemikçik onarımında protez yer değiştirebilir veya kulak zarından dışarı itilebilir; ek ameliyat gerekebilir.
- **Kulak enfeksiyonu ve akıntı** — Ameliyat sonrası kulak akıntısı veya yara enfeksiyonu olabilir; genellikle damla veya antibiyotikle düzelir. Kulak kepçesi kıkırdağının iltihabı (perikondrit) nadirdir ancak kıkırdakta şekil bozukluğu bırakabilir.
- **Kulak yolunda daralma veya zarın lateralizasyonu** — Kulak yolunda iz dokusu oluşarak daralma olabilir veya yeni kulak zarı olması gereken yerden uzaklaşabilir; işitmeyi etkileyebilir ve düzeltme işlemi gerektirebilir.
- **Kolesteatomun tekrarlaması veya kalıntı** — Kolesteatom ameliyatlarında hastaların bir kısmında hastalık tekrarlayabilir veya küçük bir kalıntı büyüyebilir; bu nedenle uzun süreli takip ve gerekirse **yeniden ameliyat** gerekir.
- **Yara ve iz sorunları** — Kulak arkası kesisinde kalınlaşmış iz veya keloid, nadiren kulak arkasında sıvı birikimi olabilir.

Nadir veya çok nadir, ancak ciddi olabilecek durumlar

- **İç kulak hasarına bağlı kalıcı işitme kaybı** — Yaklaşık 100 hastada **1'den azında** iç kulağın etkilenmesine bağlı **kalıcı sinirsel işitme kaybı** gelişebilir; çok nadiren ameliyat edilen kulakta işitme tamamen kaybolabilir (ölü kulak). Bu durum işitme cihazı veya ileri işitme rehabilitasyonu gerektirebilir. Risk, kolesteatom ve iç kulağa yakın hastalıklarda daha yüksektir.
- **Uzun süren baş dönmesi ve denge bozukluğu** — Nadiren iç kulağın etkilenmesine bağlı haftalarca süren baş dönmesi olabilir; denge egzersizleri ve ilaç tedavisi gerekebilir.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- **Yüz siniri felci** — Yüz siniri orta kulaktan geçtiği için çok nadiren (100 hastada **1'den çok daha az**) yüzün o tarafında geçici veya kalıcı güçsüzlük gelişebilir. Risk, kolesteatom, tekrarlayan ameliyatlar ve doğuştan farklı seyreden sinirlerde daha yüksektir. Gelişirse ilaç tedavisi, göz koruması ve gerekirse cerrahi müdahale (sinirin basıdan kurtarılması veya onarımı) gerekebilir. Kalıcı olursa yüzde asimetri ve gözün tam kapanmaması kalabilir; bu durumda uzun süreli göz koruması ve gerekirse yüz canlandırma ameliyatları gerekebilir.
- **Beyin zarı ile ilgili komplikasyonlar** — Özellikle mastoidektomi ve kolesteatom ameliyatlarında, kafa tabanı kemiğinin incelmiş olduğu durumlarda çok nadiren beyin-omurilik sıvısı (BOS) sızıntısı, menenjit veya beyin zarı yaralanması gelişebilir; hastanede, gerekirse yoğun bakımda ek tedavi ve ameliyat gerektirebilir; menenjit nadiren kalıcı hasar bırakabilir.
- **Kulak kepçesinin şeklinde kalıcı değişiklik** — Kulak arkası yaklaşım veya kıkırdak grefti alınmasına bağlı olarak kulak kepçesinin konumunda veya şeklinde hafif değişiklik nadiren kalıcı olabilir.

Her cerrahi / tıbbi girişim için geçerli genel riskler

- **Anestezi riskleri:** Genel anestezi veya sedasyon uygulanacaksa riskleri (bulantı, boğaz ağrısı, diş hasarı, alerjik reaksiyon, çok nadiren kalp-akciğer sorunları) anestezi uzmanı tarafından ayrıca anlatılır ve **ayrı bir anestezi onam formu** ile onayınız alınır.
- **Kanama ve kan nakli:** Bu işlemlerde kan nakli ihtiyacı çok nadirdir. Ciddi bir kanamada kan veya kan ürünü verilmesi gerekebilir; bunun da kendine özgü (alerji, enfeksiyon gibi) çok nadir riskleri vardır.
- **Enfeksiyon:** Ameliyat sonrası yara enfeksiyonu genellikle antibiyotikle tedavi edilir; nadiren drenaj (iltihabın boşaltılması) gerekebilir.
- **Bacak toplardamarlarında pıhtı (DVT) ve akciğere pıhtı atması (pulmoner emboli):** Kısa süren baş-boyun ameliyatlarında çok nadirdir. Erken hareket etmek riski azaltır. Hormon ilacı kullanımı, sigara, obezite ve önceki pıhtı öyküsü riski artırır.
- **İlaç alerjisi:** Kullanılan ilaçlara, antiseptiklere, banda veya dikiş materyaline karşı alerjik reaksiyon gelişebilir.
- **Yara izi ve iyileşme sorunları:** Kişiden kişiye değişen iz oluşumu; çok nadiren kalın (hipertrofik) iz veya keloid gelişebilir.
- **Hayati risk:** Günümüzde planlı baş-boyun cerrahisinde ölüm son derece nadirdir; ancak hiçbir cerrahi girişimin riski tamamen sıfır değildir. Ciddi bir komplikasyon hâlinde yoğun bakım tedavisi gerekebilir ve kalıcı sakatlık gelişebilir.

Bu liste mümkün olan tüm komplikasyonları kapsamaz; tıpta öngörülemeyen, çok nadir başka durumlar da ortaya çıkabilir. Bir komplikasyon gelişirse, gerekli tedavi ve takip hekiminiz tarafından planlanır; bu durum ek tedavi, ilaç, girişim veya yeniden ameliyat gerektirebilir.

9 Hemen bize ulaşmanız gereken durumlar

- **Ani ve belirgin işitme kaybı** (süngerlere bağlı tıkanıklıktan farklı, ani kötüleşme)
- **Şiddetli baş dönmesi**, kusma ve ayakta duramama
- **Yüzde güçsüzlük**: ağız kenarında kayma, gözü kapatamama
- **38,5 °C üzerinde ateş**, kulakta artan ağrı, kulak kepçesinde kızarıklık ve şişlik veya kötü kokulu, iltihaplı akıntı
- Kulaktan **berrak, sulu akıntı**, şiddetli baş ağrısı veya ense sertliği
- Pansuman veya kulaktan **durmayan kanama**

Bu durumlardan biri olursa bekletmeden hekiminizi arayınız: 0288 502 50 20 · WhatsApp 0555 333 21 20. Ulaşamazsanız en yakın acil servise başvurunuz veya 112'yi arayınız.

10 İlaçlar ve günlük yaşam ile ilgili öneriler

- Hekiminiz izin verene kadar **kulağınıza kesinlikle su kaçırmayınız**: duşta kulağınızı vazelinli pamukla tıkayınız, havuz ve denize girmeyiniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

- İlk **4–6 hafta** burnunuzu **sümkürmeyiniz**; hapşırmanız gerekirse ağzınız açık hapşırınız. Burnunuzu kapatıp ıkınmayınız (Valsalva yapmayınız).
- Ağır kaldırma, ıkınma, eğilme ve ağır egzersizden ilk haftalarda kaçınınız. Kabızlık varsa hekiminize bildiriniz.
- Uçak yolculuğu, dalış ve basınç değişikliği gerektiren aktiviteler için mutlaka hekiminizden onay alınız; **dalış** için genellikle daha uzun süre beklenmesi gerekir.
- Kulak yoluna pamuklu çubuk veya başka bir cisim sokmayınız; size verilen kulak damlalarını gösterildiği şekilde kullanınız.
- Yurt dışından geldiyseniz dönüş yolculuğunuzu hekiminizle planlayınız; dönüş sonrası kontroller ve işitme testi yerel bir KBB hekimi ile sürdürülebilir.
- Size reçete edilen ilaçları (antibiyotik, ağrı kesici vb.) önerilen doz ve sürede kullanınız. Aspirin ve benzeri kanamayı artırabilecek ilaçları hekiminize danışmadan kullanmayınız.
- Ameliyat sonrası 4 saatten uzun uçak veya kara yolculuğunda bol su için, sık sık hareket edin ve önerildiyse varis çorabı kullanın; bu, bacakta pıhtı riskini azaltır.
- İyileşme sürecinde alkol almamanız, sigara ve nikotin ürünlerinden uzak durmanız önerilir.
- Kontrol randevularınıza mutlaka geliniz. Yurt dışından geldiyseniz dönüşünüzden sonra kontroller online görüşme ve fotoğraf/video ile sürdürülebilir; yerel bir hekime başvurmanız gerekirse size ameliyat raporu ve önerilerimiz yazılı olarak verilir.

11 İşlem sırasında beklenmeyen durumlar, doku örnekleri ve kan ürünleri

İşlem sırasında önceden öngörülemeyen bir durumla karşılaşılırsa, hekiminiz yalnızca bu formda onay verdiğiniz işlemin kapsamında kalır. **Hayati tehlike veya ciddi organ zararı riski** olmadıkça onay vermediğiniz ek bir işlem yapılmaz; böyle bir durumda işlem uygun noktada sonlandırılır ve size sonradan bilgi verilerek karar birlikte alınır. Hayati tehlike durumunda ise hayatınızı veya organınızı korumak için gerekli acil müdahale yapılır.

İşlem sırasında çıkarılan dokular, gerekli görüldüğünde tanının kesinleştirilmesi için **patolojik incelemeye** gönderilir. Bu inceleme sonucuna göre ek tedavi veya takip gerekebilir.

Kan nakli ihtiyacı bu işlemlerde çok nadirdir; yalnızca hayati gerekliliği olan durumlarda uygulanır. Kan veya kan ürünü almayı kabul etmiyorsanız (örneğin inanç nedeniyle) bunu işlemden önce mutlaka bildiriniz; bu kararın olası sonuçları sizinle ayrıca konuşulur ve “Size özel bilgiler” bölümüne yazılır.

12 Fotoğraf, görüntü kayıtları ve kişisel verileriniz

Tedavinizin planlanması, takibi ve sonucun değerlendirilmesi amacıyla işlem öncesinde ve sonrasında **fotoğraf/video** çekilebilir. Bu kayıtlar sağlık dosyanızın parçasıdır ve gizli tutulur. Görüntüleriniz **hiçbir koşulda reklam, tanıtım veya sosyal medya amacıyla kullanılmaz.**

Görüntülerinizin bunun dışındaki amaçlarla kullanılması **yalnızca sizin ayrı ve açık izninizle** mümkündür. İzin vermemeniz tedavinizi hiçbir şekilde etkilemez ve verdiğiniz izni dilediğiniz zaman geri alabilirsiniz:

☐ Görüntülerimin yalnızca **tıbbi kayıt ve tedavi takibi** amacıyla kullanılmasını kabul ediyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılmayacak şekilde** (yüz/göz bölgesi kapatılarak) bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Görüntülerimin **kimliğim anlaşılabilecek şekilde** bilimsel yayın ve hekim eğitimi amacıyla kullanılmasına izin veriyorum.

☐ Bilimsel/eğitim amaçlı kullanıma **izin vermiyorum.**

Kişisel ve sağlık verileriniz 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu ve ilgili sağlık mevzuatı kapsamında, tanı, tedavi ve yasal yükümlülükler amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altındaki kişilerce işlenir. Ayrıntılı bilgi için KVKK Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz.

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

13 Size özel bilgiler ve notlar (hekim tarafından doldurulur)

Hastaya özgü ek riskler (eşlik eden hastalıklar, kullanılan ilaçlar, önceki ameliyatlar), planın ayrıntıları, hastanın beklentisi, sorduğu sorular ve verilen cevaplar. Boş kalacaksa "yoktur" yazılır.

14 Hasta beyanı

- ☐ Bu formu kendi dilimde okudum, anladım. Yeterli düşünme süresi tanındı; sorularımı sorma fırsatı buldum ve tatmin edici yanıtlar aldım.
- ☐ Durumum, önerilen işlemin amacı, nasıl yapılacağı, kim tarafından ve nerede yapılacağı, tahmini süresi, beklenen faydaları, başarı şansı, alternatifleri ve işlem yapılmazsa olabilecekler bana sözlü ve yazılı olarak açıklandı.
- ☐ Sık görülen ve ciddi olabilecek riskler ile bu komplikasyonların olası sonuçları (ek tedavi, yeniden işlem/ameliyat gerekebileceği dahil) bana anlatıldı. Tıpta hiçbir işlemin sonucunun **%100 garanti edilemeyeceğini** biliyorum.
- ☐ Sağlık durumum, kullandığım ilaçlar, alerjilerim ve geçirdiğim hastalıklar hakkında doğru ve eksiksiz bilgi verdim. Eksik veya yanlış bilgi vermemin riskleri artırabileceğini biliyorum.
- ☐ İşlem öncesi ve sonrasında verilecek talimatlara uymamın sonucun bir parçası olduğunu ve kontrol randevularına gelmenin önemini anladım.
- ☐ Onayımı işlem başlamadan önce istediğim zaman geri alabileceğimi biliyorum. Bu formu imzalamamın, hekimin özen yükümlülüğünü ortadan kaldırmadığını biliyorum.
- ☐ Bu kararı kimsenin baskısı olmadan, kendi özgür irademle veriyorum.
- ☐ Ameliyatın öncelikli amacının kulak zarını kapatmak ve kuru, güvenli bir kulak elde etmek olduğunu; işitmede düzelmenin garanti edilemeyeceğini ve nadiren işitmenin azalabileceğini anladım.
- ☐ Ameliyat sırasında bulunacak duruma göre kemikçik onarımı veya mastoidektomi gerekebileceği bana açıklandı ve bu işlemlerin yukarıda işaretlendiği şekilde yapılmasına onay veriyorum.

- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemin bana uygulanmasına ONAY VERİYORUM.**
- ☐ **Yukarıda açıklanan işlemi KABUL ETMİYORUM. Reddetmenin olası sonuçları bana anlatıldı.**

Hasta tarafından kendi el yazısıyla yazılması önerilir: "Bu formu okudum, anladım, onay veriyorum."

Op. Dr. Murat Ayata Muayenehanesi
Karacaibrahim Mah. Dereüstü Sk., Merkez / Kırklareli
Tel: 0288 502 50 20 · WhatsApp: 0555 333 21 20
info@muratayata.com · www.muratayata.com

15 İmzalar

	ADI SOYADI	İMZA	TARİH / SAAT
Hasta			
Yasal temsilci (veli / vasi) — yakınlığı:			
Bilgilendiren ve işlemi yapacak hekim			
Tercüman (gerekirse) — dil:			
Tanık (gerekirse)			

Tercüman beyanı: Bu formu ve hekimin sözlü açıklamalarını hastaya / yasal temsilciye eksiksiz ve doğru olarak, anladığı dilde tercüme ettim.

18 YAŞINDAN KÜÇÜK VEYA KARAR VERME YETİSİ KISITLI HASTALAR İÇİN

18 yaşından küçük hastalarda onam, **veli veya vasi** tarafından verilir. Çocuk, yaşı ve olgunluğuyla uyumlu biçimde bilgilendirilir ve görüşü alınır. Kısıtlı hastalarda onamı yasal temsilci verir.

☐ Velayeti birlikte kullanıyorsak, diğer ebeveynin de bu işlemden haberdar olduğunu ve onay verdiğini beyan ederim.

☐ Velayet / vesayet konusunda bir mahkeme kararı veya anlaşmazlık bulunmadığını beyan ederim (varsa hekime belgesi gösterilmiştir).

Çocuğun yaşına uygun şekilde bilgilendirildiği ve görüşü: _____

Bu form iki nüsha olarak düzenlenmiştir: bir nüshası hasta dosyasında saklanır, bir nüshası hastaya / yasal temsilciye verilir.

ONAMIN GERİ ALINMASI (YALNIZCA VAZGEÇİLMESİ HÂLİNDE DOLDURULUR)

Yukarıda verdiğim onayı geri alıyorum. Vazgeçmemin olası sonuçları bana açıklandı.

Vazgeçen hasta/temsilci adı soyadı, imza, tarih, saat: _____

Bu form, T.C. Hasta Hakları Yönetmeliği ve Türk Tabipleri Birliği Aydınlatılmış Onam ilkeleri esas alınarak hazırlanmıştır. Sözlü bilgilendirmenin yerini tutmaz, onu tamamlar.